

表 1 縦隔原発胚細胞腫瘍のリスク分類（IGCCC 分類）

非セミノーマ	セミノーマ
Good prognosis（予後良好）	
該当症例なし	腫瘍マーカーは AFP 値が正常範囲（hCG 値、LDH 値は問わない） 肺以外に転移巣は認めない
Intermediate prognosis（予後中間）	
該当症例なし	腫瘍マーカーは AFP 値が正常範囲（hCG 値、LDH 値は問わない） 肺以外に転移巣を認める
Poor prognosis（予後不良）	
縦隔原発はすべて該当	該当症例なし

mide（VIP）療法 4 コースが推奨される。化学療法後に残存病巣の摘出術を行う可能性が高いため、bleomycin による肺障害を回避するため VIP 療法を推奨するとの意見もある。導入療法後に腫瘍マーカーが正常化、もしくは救済療法で正常化した後に残存腫瘍摘出術を行う。救済療法で腫瘍マーカーが正常化しなくても、残存病変が局限していて完全切除が可能であれば、残存腫瘍切除が行われることが多い。

縦隔原発奇形種の場合は、腫瘍マーカーが正常である限り切除のみである。

縦隔原発セミノーマの 5 年無増悪生存率、5 年全生存率はそれぞれ 88%、88%で、肝転移もしくは 2 臓器以上への転移が予後不良因子である。縦隔原発非セミノーマではそれぞれ 44%、45%とセミノーマに比べて予後不良であり、肝臓、鎖骨上リンパ節への転移が予後不良因子である³⁾。

治療後の性腺機能障害や二次癌、心血管毒性のリスクがあり、こうした晩期合併症への対策も重要となる。具体的には、治療前からの精子凍結保存による妊孕性温存療法や治療後 5 年以上の長期的な経過観察が考慮される。

文 献

- 1) Bokemeyer C, et al : J Clin Oncol **20** : 1864, 2002
- 2) Chaganti RS, et al : Lancet **343** : 1130, 1994
- 3) 日本泌尿器科学会ほか（編）：精巣腫瘍取扱い規約，第 2024 年度版，金原出版，2024
- 4) Looijenga LHJ, et al : Am J Surg Pathol **44** : e66, 2020
- 5) Pierorazio PM, et al : J Urol **203** : 894, 2020
- 6) Fosså SD, et al : Ann Oncol **14** : 1412, 2003
- 7) Hartmann JT, et al : J Natl Cancer Inst **93** : 1733, 2001
- 8) Bokemeyer C, et al : Cancer **91** : 1394, 2001